

Trójkąt *konfliktu*

Impuls → lęk → obrona. Mapa wewnętrznego konfliktu i centralne narzędzie STPP. Terapeuta zauważa obronę, ujawnia lęk, prowadzi do ukrytego uczucia.

CZAS: 25 min Sesja 2-3; gdy pacjent opisuje konkretną sytuację **ŹRÓDŁO:** Malan (1979); Davanloo (1990)

JAK UŻYWAĆ

Rysujesz pacjentowi trójkąt i objaśniasz trzy wierzchołki. **Impuls/afekt (I):** pierwotne poruszenie — złość, żal, tęsknota, pragnienie, radość. **Lęk (L):** reakcja na ten impuls — napięcie, niepokój, pobudzenie ciała. **Obrona (O):** automatyczna strategia chroniąca przed lękiem — unikanie, intelektualizacja, somatyzacja, racjonalizacja. Bierzesz konkretną sytuację pacjenta i mapujecie trójkąt razem.

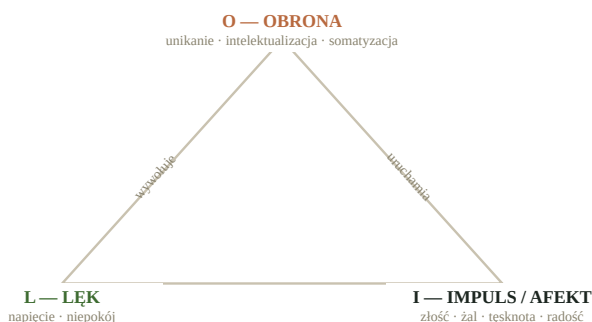
DLACZEGO TO DZIAŁA

Sekwencja: sytuacja wyzwala impuls → impuls wywołuje lęk → lęk uruchamia obronę. W patologii obrony stają się **sztywne i kosztowne** — blokują dostęp nie tylko do uczucia, ale i do vitalności. Cel STPP to stopniowa redukcja obron i doświadczenie afektu w bezpiecznym kontekście (Davanloo: „odblokowanie nieświadomego”, ang. *unlocking the unconscious*). Trójkąt stosuje się do każdej sytuacji — w czasie rzeczywistym w sesji, wobec bliskich, wobec terapeuty.

01



Trójkąt konfliktu (I-L-O)



Cel STPP: redukcja obron → kontakt z afektem → integracja. „Nie chcemy wyłączyć obron — są potrzebne. Ale gdy są zbyt sztywne, blokują też życie.”

02 Zmapuj konkretną sytuację

Weź realną sytuację pacjenta: „wczoraj, gdy mąż się spóźnił — co pojawiło się najpierw?” Zaczynij od wierzchołka, do którego pacjent ma dostęp (zwykle obrona), i schodźcie głębiej.

OBRONA

— co zrobił/-a

LĘK

— co w ciebie

IMPULS

— uczucie pod spodem

03 Wskaż cel pracy

Wyjaśnij, że celem nie jest pozbycie się obron, lecz ich rozluźnienie. „Chcemy, żeby uczucie znów było dostępne — bez obrony, która je odcina.” Zapisz, którą obronę warto rozluźnić najpierw.

OBRONA DO ROZLUŻNIENIA W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI

04 Ślad afektu

Najbardziej dostępny jest impuls — to cel pracy. Zapisz uczucie, które wybrzmiało, gdy obrona się rozluźniła (choćby na chwilę). To wskazówka, dokąd zmierza terapia.

AFEKT, KTÓRY WYBRZMIAŁ

Klucz: zaczynaj od wierzchołka, do którego pacjent ma dostęp. Większość zaczyna od obrony („rozmawiałam logicznie”), potem lęk („ale serce wali”), najbardziej impuls. Nie przyspieszaj — kontakt z afektem przychodzi, gdy obrona się rozluźni, a nie na żądanie.